

DOR TORÁCICA



ROTINA CLÍNICA

Modelos de prescrição

TRATAMENTO

Desmistificando o “MONABCH”

Protocolo de IAM



- M** - Morfina
- D** - Oxigênio
- N** - Nitratos
- A** - AAS
- B** - Betabloqueadores
- C** - Clopidogrel
- H** - Heparina



ROTINA CLÍNICA

TRATAMENTO

PRECISA SER UTILIZADO TODO O

“MONABCH” ??

“NAO”

Importante: gravar o acrônimo **NAO**, o qual será abordado em detalhes a seguir.



ROTINA CLÍNICA

TRATAMENTO

Atualizações:

1º Morfina: não reduz mortalidade, aumenta o risco de rebaixamento de drive respiratório e eleva a incidência de intubação orotraqueal.

2º Clopidogrel (2º antiplaquetário): deve ser realizado apenas na sala de cateterismo quando a anatomia coronariana é conhecida e a intervenção coronária percutânea (ICP) foi realizada (desde que haja possibilidade de cateterismo em até 24h) ou na emergência em caso de trombólise química.



TRATAMENTO

Atualizações:

3º Betabloqueador: pode aumentar a incidência de choque cardiogênico, principalmente quando utilizado nas primeiras 24 a 48h de evolução.

4º Heparina (anticoagulante): dependerá necessariamente se o paciente receberá intervenção coronária percutânea ou não. Isso é determinado na sala de hemodinâmica.

Sugestão prática: NÃO REALIZAR*, desde que o paciente vá para o cateterismo em menos de 24h.



TRATAMENTO

Controle álgico:

- **Nitrato sublingual:**

Mononitrato de isossorbida (Monocordil 5 mg)

Dose: realizar até 3 comprimidos (15 mg) espaçados a cada 5 minutos.

- **Nitrato endovenoso:**

Nitroglicerina (Tridil)

Dose: 10µg/min com incrementos de 10µg a cada 5min

Diluição padrão: 1 ampola de 5 ml de Nitroglicerina + 245 ml de SF 0,9%.

Prática: iniciar a 3 ml/hora e ajustar a titulação de 3 em 3 ml a cada 5 minutos.



ROTINA CLÍNICA

TRATAMENTO

Antiagregação plaquetária:

Ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg
Administrar **3 comprimidos (300 mg)**
em todos os casos de SCA.

Infarto com supra de ST:

Em locais onde há disponibilidade de
transferência para o cateterismo de
urgência - **600 mg de clopidogrel.**

Clopidogrel 75 mg ----- **8 comprimidos!**
Administrar em tomada única!

Observação! Se trombólise química:
300 mg de clopidogrel e apenas 75 mg
em pacientes acima de 75 anos.



ROTINA CLÍNICA

TRATAMENTO

Antiagregação plaquetária:

Infarto sem supra de ST:

Sem disponibilidade de transferência para o cateterismo em até 24h.

Ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg

Administrar **300 mg** em todos os casos de SCA.

Clopidogrel 75 mg ----- 4 comprimidos

Administrar em tomada única!

Dose total de 300 mg de clopidogrel.

→ Se houver a possibilidade de transferência para o cateterismo em até 24h, administrar apenas o AAS.



ROTINA CLÍNICA